Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 7ª Vara Cível da Capital

, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0013969-11.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): EDUARDO JOSE FERREIRA BEZERRA DE SOUZA

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

-

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.

- Contrato de seguro saúde anterior à lei 9.656 (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104153/lei-9656-98)/98 e não adaptado.

- O STF, no julgamento do RE 948.634 (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4928717)/RS, recurso com tema representativo submetido à Repercussão Geral, Tema 123, entendeu pela irretroatividade da Lei 9.656/1998, decidindo por sua não aplicação aos contratos firmados anteriormente à sua vigência e não adaptados.

- Enunciado 33, da i jornada de direito da saúde do CNJ, que recomenda aos magistrados a análise dos pareceres técnicos da agência nacional de saúde suplementar e da comissão nacional de incorporação de tecnologias no SUS (CONITEC) na prolatação de decisão.

- Atenção à lei 9.656/98 ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, RN nº 465, de 24/02/2021.

- Fornecimento de medicamentos não oncológicos - recusa amparada nas exceções do art. 10, VI, da lei 9.656/98; inciso VI do parágrafo único do art. 17 da RN nº 465, de 24/02/2021; parecer técnico nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021.

.

Vistos etc.

EDUARDO JOSÉ FERREIRA BEZERRA DE SOUZA, qualificado, mediante advogado, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, igualmente identificada.

Requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita e negando interesse na realização da audiência de conciliação ou mediação, disse ser portador de fibrose pulmonar idiopática (CID: J 84.1), tendo, em 23/01/2024, sido a si prescrito o uso contínuo de medicação antifibrótica PIRFENIDONA 267 mg (ESBRIET - ANVISA 101000663017), a ser tomada em 03 (três) capsulas, de 08/08 horas, de forma contínua e sem previsão de suspensão, conforme Receituário Médico – Laudo Médico da médica pneumologista Dra. Marília Montenegro Cabral, CRM: 13826.

Afirmou ter a médica que o acompanha deixado claro ser a fibrose pulmonar idiopática uma doença crônica de natureza gravíssima, que degenera o pulmão e evolui, de modo crescente, para insuficiência respiratória e óbito.

Apontou ter a última caixa do medicamento sido fornecida pelo SUS, sendo, porém, informado não mais haver a medicamento disponível, tendo que aguardar tempo indeterminado.

Disse haver solicitado cobertura à ré, sendo-lhe negado o fornecimento, por supostamente não fazer parte do programa de atendimento, protocolo número 34665920240201014141.

Discorreu sobre a necessidade de uso da medicação ESBRIET (PIRFENIDONA 267 mg), justamente por estar "presente em diretrizes internacionais para o tratamento de pessoas com o diagnóstico acima citado e liberado em diversos países", com "evidência disponível mostrando redução da progressão da doença com o uso da medicação indicada", acarretando conclusão favorável no sentido da existência de elementos técnicos para respaldar a indicação da medicação.

Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a demandada seja compelida a custear integralmente o tratamento, na forma prescrita pela especialista: PIRFENIDONA 267 mg (ESBRIET - ANVISA 101000663017), a ser tomado em 03 (três) capsulas, de 08/08 horas, de forma contínua e sem previsão de suspensão. No mérito, pediu confirmação da tutela e indenização por danos morais de R$ 15.000,00. Acostou documentos.

Ordem de emenda para: "*a) acostar cópia do instrumento de contrato firmado com a demandada de forma legível, eis que imprescindível que seja especificado e provado qual o tipo de pacto firmado, a data e as suas condições; b) apresentar os três últimos comprovantes de pagamento das parcelas do contrato: c) esclarecer se o laudo foi exarado por médicos credenciados à demandada; d) efetuar pedido certo e determinado, nos moldes do art. 322 e 324, do CPC, esclarecendo e quantificando o pedido, com valor total e detalhado do tratamento pugnado, não podendo ser genérico o pedido, cabendo sua quantificação; e) retificar o valor atribuído à causa, levando em consideração o valor do tratamento/exame pretendido somado ao valor do dano moral, de acordo com o disposto no art. 292, VI, e § 2º, do CPC, diante da cumulação de pedidos. f) trazer aos autos comprovante de seus rendimentos mensais atualizados e, se dependente, de seu responsável financeiro, extratos de cartão de crédito, declaração de bens, cópia do imposto de renda, e fatura de energia elétrica e água, nos moldes do art. 99, §2, do CPC, após o que apreciarei o pleito de gratuidade da justiça."* (id 160579956).

Manifestação da parte autora na peça de id 160702373, dizendo ser a médica que a acompanha credenciada à ré e indicando ser o custo total do ano equivalente a R$ 60.000,00, retificando o valor atribuído à causa para R$ 75.000,00. Acostou documentos.

Decisão alterando o valor da causa para R$ 75.000,00, deferindo o pedido de gratuidade da justiça e indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id 161042142).

Decisão em sede de Agravo de Instrumento n. 0006469-43.2024.8.17.9000: "*Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela*" (id 171723956).

Contestação aventando ter sido feito pedido genérico, impugnando o valor da causa por ser irrazoável e a concessão da gratuidade da justiça.

Afirmou não ser caso de aplicação do CDC, por se tratar de entidade assistencial, sem fins lucrativos.

Asseverou ter o autor requerido cobertura a medicamento de uso domiciliar denominado de "ESBRIET 267 MG" para tratamento de seu quadro, sendo medicação que não possui correlação com internação domiciliar, nem requer aplicação por profissional médico/enfermeiro, comercializado publicamente a pessoas físicas comuns e auto administrado pelo paciente.

Disse ser entendimento do STJ em caso análogo de medicamento de uso domiciliar, determinando que apenas quando prestados em internação ou assistência domiciliar, ou relacionados à neoplasia, devem ser cobertos, que culminou no Informativo nº 694 de 3 de maio de 2021, sendo caso de aplicação do art. 248/CC e art. 537 do CPC, de forma a eximir a operadora de qualquer responsabilidade relativa a produção, comercialização ou distribuição do medicamento, pois não possui correlação com neoplasia ou requer aplicação/uso por profissional em internação, não havendo cobertura.

Apontou que a negativa de um medicamento domiciliar não é pautada por estar Fora do Rol da ANS, não havendo dever de cobertura de medicamentos farmacêuticos, alimentos, suplementos ou qualquer outro insumo de uso domiciliar prescritos por médicos, por não fazerem parte da natureza do contrato de um plano de saúde, conforme entendimento da ANS e do STJ.

Refutou haver danos morais a indenizar. Pediu a improcedência dos pedidos autorais. Acostou documentos.

Intimação da parte autora para réplica e das partes para indicação de possibilidade de composição ou outras provas a produzir.

Peça da ré negando ter provas a produzir.

Réplica reafirmando os termos da inicial e peça negando ter provas a produzir.

É o relatório, passo à decisão.

Cuida-se da hipótese de questão que dispensa dilação probatória, uma vez que os elementos presentes, inclusive a prova documental, já são suficientes para emitir a sentença.

A emenda de id 160702373 tornou o pedido certo e determinado, descabendo a irresignação da parte ré.

No tocante ao valor da causa, esse foi atribuído com base no importe da medicação pretendida, cumulado com o pedido de indenização, de forma a atender o art. 292, V e VI do CPC;

Afasto a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, por ter sido deferida à luz das provas ofertadas, sem contraprova pela parte impugnante.

Com relação uso do CDC ao presente, descabe sua aplicação por se tratar de entidade assistencial, sem fins lucrativos, conforme a Súmula 608 do STJ, "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*" (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

A jurisprudência pátria vem sofrendo para estabelecer decisões em casos de cobertura de procedimentos por contratos de assistência à saúde, pois, de um lado, há toda uma gama de direitos estabelecidos em favor da saúde, personalidade e consumidor, havendo, porém, a necessidade de preservação da viabilidade econômica das empresas que ofertam tais pactos e do equilíbrio das contraprestações.

Para tanto, este juízo tem se amparado das normas que lastram ambas as vertentes e das normativas do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), criado pela Lei 9.656/1998, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, instituída pela Lei 9.961/00, para regulação e fiscalização das atividades que garantam assistência suplementar.

Ressalto que o Enunciado 33, da I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ, dispõe aos magistrados que atentem para os pareceres técnicos das agências reguladoras:

> "*ENUNCIADO N.º 33 Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar* e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)** para auxiliar a prolatação de decisão ou a propositura da ação."*

As Diretrizes de Utilização (DUT) são regras e normas elaboradas pela Agência Nacional de Saúde (ANS) que servem para orientação e regulamentação do uso adequado de procedimento médicos e exames complementares, sendo descritas e baseadas em estudos médicos com a finalidade de utilização das novas tecnologias ou exames que realmente possam trazer benefícios para o paciente ou que auxiliem os médicos no diagnóstico de doenças.

Ressalto que o chamado Plano de Referência foi instituído pelo art. 10 da lei 9.656/98 como aquele com "*cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (...)"* (redação da MP 2.177-44/2001).

Afere-se que mesmo o plano de referência não possui cobertura ilimitada, pois há exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS.

O pedido foi de **fornecimento de medicamentos**, cabendo ser observado que mesmo o plano de referência não possui tal cobertura, havendo exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS. Assim o art. 10 da lei 9.656/98:

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, *ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013)* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art2) *(Vigência)* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art3)

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente."

Algumas dessas exceções constam do inciso VI do parágrafo único do art. 17 da RN nº 465, de 24/02/2021:

"Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
Parágrafo único. ***São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:***
(...)
VI - ***fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,*** *isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;*

O PARECER TÉCNICO Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021[1] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20%20Fibrose%20Pulmonar%20-%20NOVA%20RES.docx#_ftn1), que trata dos medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, diz ser obrigatória a cobertura para:

"a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 18, inciso XI, da RN n.º 465/2021), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN n.º 465/2021; e

b) Medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei n.º 9.656/1998 c/c art. 13, da RN n.º 465/2021.

c) Medicamentos que eventualmente constem em contrato ou aditivo contratual acordado entre as partes."

No presente caso, **não se trata de pedido de fornecimento de medicação oncológica domiciliar**, mas de medicação antifibrótica PIRFENIDONA 267 mg (ESBRIET - ANVISA 101000663017), a ser tomada em forma de cápsulas, para tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID: J 84.1), conforme laudos de ids 160424462, 160424463 e 160424464.

Assim, não se trata de negativa de um exame ou de um tratamento hospitalar, mas de **medicamentos de uso domiciliar e não oncológico**, a ser ministrado em cápsulas no domicílio do autor, não estando coberto pelo contrato firmado e nem constando no rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela ANS (RN nº 465/2021), pelo que descabe cobertura, enquadrando-se, o presente pedido, na exceção do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, inciso VI do parágrafo único do art. 17 da RN 465/2021, além do PARECER TÉCNICO Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, não sendo obrigatório seu fornecimento pelo plano de saúde.

Trago à luz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

> *"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1989033 DF 2022/0062136-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)"* (grifos para destacar)
>
> *"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE S AÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA COMO NEOPLÁSICO. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte: É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios*

termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2031280 MG 2022/0317722-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)" (grifos para destacar)

Incluo julgados do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Autora portadora de trombocitopenia imune (PTI), sendo-lhe prescrito tratamento com uso contínuo do medicamento Revolade 50mg. 2. Medicamento de uso domiciliar; lícita a conduta do plano de saúde que se recusa a custear medicamento expressamente excluído da cobertura. 3. Obrigar as seguradoras a cobrir os medicamentos de uso domiciliar prescritos pelos médicos assistentes resultaria em significativo aumento dos custos, e, sem o aumento da contraprestação, se estaria a lesionar a comutatividade e o equilíbrio contratual. 4. O art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 possibilita às operadoras restringirem o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, razão pela qual a limitação está em consonância com a legislação pertinente e não se mostra abusiva frente aos princípios e normas que regem os direitos do consumidor. 5. Destaque-se que não se está diante de negativa de medicamento substituto das internações hospitalares ou ambulatoriais para sessões de quimioterapia, isso porque os medicamentos utilizados em concomitância com a quimioterapia e radioterapia não se inserem na regra de exclusão do artigo 10, VI, da lei 9656/98, que permite a exclusão contratual do fornecimento de medicação domiciliar. 6. O medicamento requerido não se encaixa em nenhuma das hipóteses de cobertura previstas na Lei n. 9.656/1998, não havendo, bem por isso, obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde. 7. Sentença reformada. 8. Provimento do recurso. (TJ-PE - AC: 00007095520228172640, Relator: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (1ª TCRC))" (grifos para destacar)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MONITOR E SENSOR CONTÍNUO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS ÍNDICES GLICÊMICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUSTEIO PELA SEGURADORA. TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O cerne da demanda consiste em averiguar o dever da Agravada em custear o tratamento perseguido nos autos - monitor e sensor contínuo de glicemia (FREESTYLE LIBRE). - Conforme estabelecido na Lei nº 9.656/98 e precedentes do c. STJ, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados (arts. 10, VI e 12, I, c e II, g, da Lei 9.656/98). - Portanto, encontram-se excluídos da cobertura pelos planos de saúde aquelas medicações/insumos adquiridos facilmente em farmácias e cuja aplicação (uso) pode se dar no âmbito domiciliar (Precedentes c. STJ). - Do mesmo modo, diante da desnecessidade de intervenção médico-cirúrgicas relacionadas ao fornecimento do aparelho, encontram-se excluídos da cobertura obrigatória pelas operadoras, nos termos do art. 10, VII, da Lei de regência. - Recurso desprovido. (TJ-PE - AI: 00166532920228179000, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)" (grifos para destacar)"

"PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AFASTAR JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA E PRELIMINAR DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS REJEITADA. MEDICAMENTO INVEGA SUSTENA. ESQUIZOFRENIA CRONICA. NEGATIVA. DOMICILIAR (NENHUMA HIPOTESE DO ARTIGO art. 10,VI, e 12 da Lei nº 9.656/1998. FÁRMACO QUE NÃO SE RELACIONA A TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO, NEM DE USO HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. EXCLUSÃO ANS. ROL TAXATIVO. RECUSO DA RÉ PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer

medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e outros fármacos incluídos pela ANS no rol de fornecimento obrigatório. Precedentes STJ. 2. In casu, EMBORA comprovada a necessidade de a paciente utilizar o medicamento solicitado como única terapia disponível, o Plano de Saúde não possui o dever de custear o medicamento de uso domiciliar (Invega Sustenna), pois extrapolaria os limites contratuais e legais, 3. Dado o provimento do recurso, inverte-se a sucumbência e fixa-se honorários advocatícios em R$ 500,00. 4. Recurso provido. (TJ-PE - AC: 00702011920198172001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))" (grifos para destacar)"

Ante o exposto, **julgo improcedentes** os pedidos, em contraposição à tutela de id 171723956.

Condeno a parte demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao procurador adversário, com base no art. 85, § 2º, do CPC, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, que suspendo conforme art. 98, §5°, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos.

Recife, 19 de julho de 2024.

IASMINA ROCHA

Juíza de Direito

---

[1] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20%20Fibrose%20Pulmonar%20-%20NOVA%20RES.docx#_ftnref1) https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_20_2021_medicamentos_para_tratamento_domiciliar.pdf (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_20_2021_medicamentos_para_tratamento_domiciliar.pdf)> ACESSO EM 02/08/2023.

Assinado eletronicamente por: IASMINA ROCHA
19/07/2024 12:03:39
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 176336172

24071912033928900000172109678

IMPRIMIR GERAR PDF